

医药生物

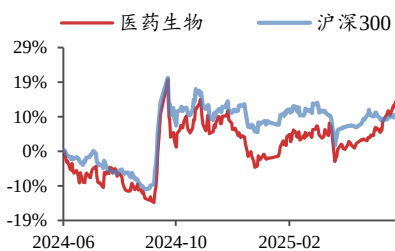
2025 年 06 月 15 日

SYS6010:广谱抗肿瘤大品种，早期 NSCLC 数据优异

——行业周报

投资评级：看好（维持）

行业走势图



数据来源：聚源

相关研究报告

《关注 Protac 自免赛道积极进展——行业周报》-2025.6.8

《重视 Pharma 估值重塑的机会——行业周报》-2025.6.2

《经营拐点显现，动保业务有望贡献较大业绩弹性，推荐国邦医药——行业周报》-2025.5.25

余汝意（分析师）

yuruyi@kysec.cn

证书编号：S0790523070002

余克清（分析师）

yukeqing@kysec.cn

证书编号：S0790525010002

聂媛媛（联系人）

nieyuanyuan@kysec.cn

证书编号：S0790124050002

● SYS6010（EGFR ADC）：广谱抗肿瘤大品种，早期 NSCLC 数据优异

截至 2025 年 6 月，全球共 6 款 EGFR 单抗 ADC 药物进入临床，尚无获批上市药物。全球进度最快的是乐普生物的维贝柯妥塔单抗，已于 2025 年 3 月在中国递交针对鼻咽癌适应症 NDA 申请，美国于 2023 年 10 月获批进入临床。石药的 SYS6010 在国内针对 EGFR 突变 NSCLC 已开展两项注册 III 期临床，海外于 2023 年进入临床 I 期。

SYS6010 治疗 NSCLC 已经入中国注册 III 期临床阶段，并广泛布局乳腺癌、结直肠癌、食管癌等适应症。截至 2025 年 6 月，公司已针对 SYS6010 开展两项中国 NSCLC 注册 III 期临床和多项早期探索性试验。SYS6010 针对 NSCLC 适应症已获得 FDA 的 3 项快速通道资格认定和 NMPA 的 1 项突破性疗法认定。多项早期临床广泛探索 SYS6010 单药或联合恩朗苏拜单抗（PD-1 单抗）、贝伐珠单抗（VEGF 单抗）、SYH2051（ATM 抑制剂）或希美替尼（CSF1R/FGFR/VEGFR2 小分子抑制剂）在不同适应症中的治疗潜力。

第三代 EGFR-TKI 一线治疗 EGFR 突变 NSCLC 的用药方案已在全球占据主流地位，但 EGFR-TKI 耐药患者缺少安全有效的后线治疗方案。第三代 EGFR TKI 耐药后的治疗策略可以大致分为四类，包括 EGFR 靶点联合用药（或 EGFR 双抗）、免疫联合化疗、新一代 EGFR 抑制剂以及抗体偶联药物 ADC。

SYS6010 治疗 EGFR TKI 耐药 NSCLC 患者的 mPFS 明显延长，EGFR 野生型患者 ORR 数据优异。SYS6010 是全球首个在肺癌领域开展注册 III 期的 EGFR ADC，于 2025 年 AACR 大会披露的早期数据十分优异。SYS6010-001（CTR20231332）是 SYS6010 首个中国临床试验，根据于 2025AACR 披露的早期数据显示，SYS6010 三线及三线后治疗一线使用 EGFR TKI、二线使用含铂化疗后的非鳞状 NSCLC 患者后，患者 mPFS 长达 7.6 个月；二线治疗数据尚未成熟。经治疗后的 164 例患者发生的三级及以上的 TRAE 为 51.2%，显示 SYS6010 兼具较好的安全性。SYS6010 后线治疗 7 例 EGFR 野生型 NSCLC 患者的 ORR 达到 71.4%，数据优异。

● 推荐标的

推荐标的：制药及生物制品：恒瑞医药、华东医药、三生制药、人福医药、恩华药业、信达生物、百利天恒、泽璟制药-U、诺诚健华、科伦博泰生物-B、三生国健、康诺亚、一品红、海思科、艾力斯、艾迪药业、和黄医药、京新药业、健康元；**CXO：**药明康德、药明合联、泰格医药、药明生物、博腾股份、泓博医药；**科研服务：**毕得医药、百普赛斯、皓元医药、昊帆生物、海尔生物、奥浦迈、阿拉丁；**中药：**东阿阿胶、江中药业、天士力、济川药业、羚锐制药、悦康药业、方盛制药、佐力药业；**原料药：**普洛药业、健友股份、华海药业、奥锐特、博瑞医药；**医疗器械：**迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗、澳华内镜、英科医疗、万孚生物、可孚医疗、圣湘生物、康拓医疗；**医疗服务：**爱尔眼科、通策医疗、美年健康、海吉亚医疗、锦欣生殖；**零售药店：**益丰药房。

● **风险提示：**政策落地不及预期、行业整合不及预期、行业竞争格局恶化等。

目 录

1、SYS6010：广谱抗肿瘤大品种，NSCLC 早期数据优异	3
2、6 月第 2 周医药生物上涨 1.4%，医疗研发外包涨幅最大	7
2.1、板块行情：本周医药生物上涨 1.4%，跑赢沪深 300 指数 1.66pct.....	7
2.2、子板块行情：医疗研发外包涨幅最大，疫苗跌幅最大.....	7
3、风险提示	9

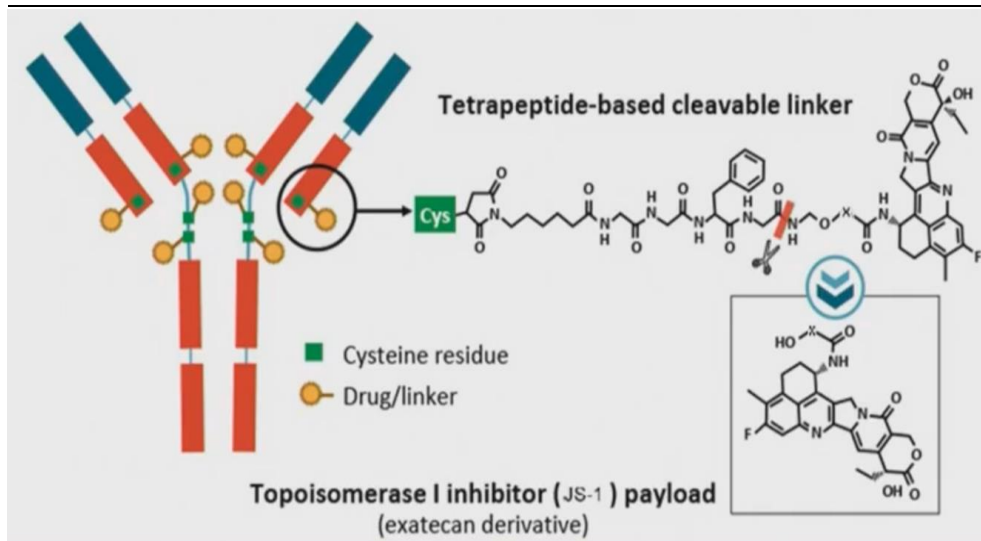
图表目录

图 1：SYS6010 是公司自研的 DAR 值为 8 的 EGFR ADC	3
图 2：EGFR 突变 NSCLC 患者推荐用药（CSCO 及 NCCN 指南）	5
图 3：SYS6010 早期数据优异.....	6
图 4：6 月医药生物指数上涨 2.55%（单位：%）	7
图 5：6 月第 2 周医药生物上涨 1.4%（单位：%）	7
图 6：医疗研发外包涨幅最大，疫苗跌幅最大.....	7
表 1：截至 2025 年 6 月，全球共 6 款 EGFR 单抗 ADC 药物进入临床	3
表 2：SYS6010 采用高 DAR 值低毒素设计，临床前数据优于 MMAE 或 Dxd 等 ADC.....	4
表 3：SYS6010 广泛布局 NSCLC、乳腺癌、结直肠癌、食管癌等适应症.....	4
表 4：6 月以来化学制药和化学制剂板块涨幅领先.....	8
表 5：子板块中个股涨跌幅（%）前 5.....	8

1、SYS6010：广谱抗肿瘤大品种，NSCLC 早期数据优异

SYS6010 是巨石生物（石药子公司）自主研发的 EGFR 抗体偶联药物（EGFR ADC），目前已广泛布局 NSCLC、乳腺癌、食管癌、结直肠癌等适应症。SYS6010 抗体部分是重组人源化 EGFR 单抗（JMT101），抗体部分通过四肽连接子 GGFG 偶联拓扑异构酶 I 抑制剂（Dxd 类似物）。SYS6010 可特异性结合到表达 EGFR 的细胞表面并通过内吞进入细胞，在溶酶体内被蛋白酶降解，释放毒素小分子（Dxd 类似物）。Dxd 类似物与 DNA 形成稳定复合物，诱导 DNA 损伤，进而导致细胞凋亡。表皮生长因子受体（EGFR）在多种瘤种中高表达，如 NSCLC、鼻咽癌、头颈鳞癌、三阴性乳腺癌等瘤种中，具有广谱抗肿瘤潜力。

图1：SYS6010 是公司自研的 DAR 值为 8 的 EGFR ADC



资料来源：2025 AACR 大会

截至 2025 年 6 月，全球共 6 款 EGFR 单抗 ADC 药物进入临床，尚无获批上市药物。全球进度最快的是乐普生物的维贝柯安塔单抗，已于 2025 年 3 月在中国递交针对鼻咽癌适应症的 NDA 申请，美国于 2023 年 10 月获批进入临床。石药的 SYS6010 在国内针对 EGFR 突变 NSCLC 已开展两项注册 III 期临床，海外于 2023 年进入临床 I 期。

表1：截至 2025 年 6 月，全球共 6 款 EGFR 单抗 ADC 药物进入临床

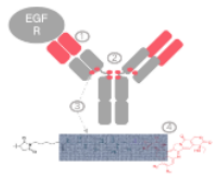
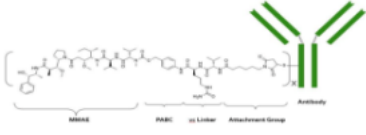
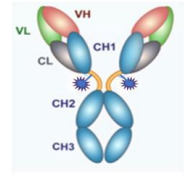
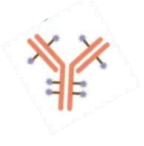
药品成分	研发机构	全球最高状态	中国内地最高状态	中国内地最高状态时间	美国最高状态	美国最高状态时间
维贝柯安塔单抗	乐普生物	申请上市	申请上市	2024/9/25	批准临床	2023/10/30
SYS6010	石药集团	临床 III 期	临床 III 期	2024/8/26	临床 I 期	2023/7/17
BB-1705	百力司康	临床 I/II 期	临床 I/II 期	2022/1/19	-	-
HLX42	宜联生物/复星医药	临床 I 期	临床 I 期	2024/1/8	批准临床	2023/11/23
DXC004A	多禧生物	临床 I 期	临床 I 期	2022/11/4	-	-
ALX2004	ALX Oncology	批准临床	-	-	批准临床	2025/4/7

资料来源：Insight、开源证券研究所

SYS6010 采用高 DAR 值低毒素设计，临床前数据显示药效均显著优于基于 MMAE 或 Dxd 等成熟毒素的对照 ADC 药物。SYS6010 的抗体部分为靶向 EGFR 的重组人源化抗体 JMT101，采用 DAR 值为 8 的设计，通过四肽连接子 GGFG 偶联拓

扑异构酶 I（Dxd 类似物）。临床前数据显示，SYS6010 对 EGFR 高表达的人结肠癌、人乳腺癌移植瘤模型具有抗肿瘤作用，对多种移植瘤模型具有显著抗肿瘤作用，且药效均显著优于基于 MMAE 或 Dxd 等成熟毒素的对照 ADC 药物。

表2：SYS6010 采用高 DAR 值低毒素设计，临床前数据优于 MMAE 或 Dxd 等 ADC

药物	SYS6010	维贝柯妥塔单抗	BB-1705	HLX42
公司	石药	乐普生物	百力司康	宜联生物/复星医药
示意图				
靶点	EGFR	EGFR	EGFR	EGFR
抗体	JMT101	JMT101	EGFR 抗体（亲和力优化）	高度特异性的 EGFR 抗体
linker	GGFG 可断裂四肽	缬氨酸-瓜氨酸 VC(可裂解)	缬氨酸-瓜氨酸 VC(可裂解)	多肽连接子(可裂解)
Payload	Dxd 类似物	MMAE	Eribulin	拓扑异构酶 I
DAR 值	8	4	2	8
旁观者效应	√	√	√	
药物	SYS6010	维贝柯妥塔单抗	BB-1705	HLX42

资料来源：2022 CSCO、2025 AACR、复星医药公众号、石药 2025Q1 公开交流 PPT 等、开源证券研究所

SYS6010 治疗 NSCLC 已经入中国注册 III 期临床阶段，并广泛布局乳腺癌、结直肠癌、食管癌等适应症。截至 2025 年 6 月，公司已针对 SYS6010 开展两项中国 NSCLC 注册 III 期临床和多项早期探索性试验。SYS6010 针对 NSCLC 适应症已获得 FDA 的 3 项快速通道资格认定和 NMPA 的 1 项突破性疗法认定。多项早期临床广泛探索 SYS6010 单药或联合恩朗苏拜单抗（PD-1 单抗）、贝伐珠单抗（VEGF 单抗）、SYH2051（ATM 小分子抑制剂）或希美替尼（CSF1R/FGFR/VEGFR2 小分子抑制剂）在不同适应症中的治疗潜力。

表3：SYS6010 广泛布局 NSCLC、乳腺癌、结直肠癌、食管癌等适应症

适应症	临床阶段	试验编号	实验组	对照组	试验公示时间	PCD
非小细胞肺癌	中国 III 期	CTR20243230	CPO301+奥希替尼	奥希替尼	2024/8/26	2026/7/30
	中国 III 期	NCT06927986	CPO301	含铂双药化疗	2025/3/18	
	中国 I/II 期	CTR20243338	SYS6010+恩朗苏拜单抗±化疗		2024/9/8	
	中国 I 期	CTR20231332	CPO301	-	2023/5/15	2025/4/27
EGFR 阳性 BC	中国 I/II 期	NCT06775236	SYS6010±SYH2051	化疗	2024/12/23	2027/6/15
EGFR+ CRC、胃癌等实体瘤	中国 I/II 期	CTR20244350	SYS6010+SYH2051±贝伐珠单抗		2024/11/19	
实体瘤	中国 II 期	CTR20242983	CPO301	-	2024/8/13	
2L+食管癌	中国 I 期	ChiCTR2400089300	SYS6010+恩朗苏拜单抗±希美		2024/9/5	2025/8/31

替尼

NSCLC、BC、CRC 等

海外 I 期

NCT05948865

CPO301

-

2023/7/17

2025/6/13

资料来源：Insight、开源证券研究所

SYS6010 单药或联合奥希替尼治疗 EGFR 突变 NSCLC 已在中国开展两项注册临床，是全球首个在肺癌领域开展注册 III 期的 EGFR ADC，早期显示 BIC 潜力。

第三代 EGFR-TKI 一线治疗 EGFR 突变 NSCLC 的用药方案已在全球占据主导地位，但 EGFR-TKI 耐药患者缺少安全有效的后线治疗方案。根据 Insight 数据，60% 患者在接受 EGFR TKI 会发生耐药。根据非小细胞肺癌 CSCO 诊疗指南（2024 版），使用第三代 EGFR TKI 进展后，患者推荐使用含铂双药化疗联合或不联合贝伐珠单抗或联合信迪利单抗及贝伐珠单抗。根据 NCCN 指南，二线用药推荐埃万妥单抗联合用药方案（未使用埃万妥单抗的患者）及阿法替尼联合西妥昔单抗（腺癌或鳞癌患者）。EGFR-TKI 耐药患者目前亟需安全有效的后线治疗方案。

图2：EGFR 突变 NSCLC 患者推荐用药（CSCO 及 NCCN 指南）

CSCO指南（2024年）		
	I级推荐	II级推荐
一线治疗方案	奥希替尼/阿美替尼/伏美替尼/贝福替尼/阿法替尼/达可替尼等	奥希替尼或吉非替尼或厄洛替尼+化疗 /厄洛替尼+贝伐珠单抗 /含铂双药化疗±贝伐珠单抗（非鳞癌）
后线治疗方案	T790M+：奥希替尼/阿美替尼/伏美替尼/贝福替尼 T790M-或三代TKI治疗失败：含铂双药±贝伐珠单抗20号外显子+：舒沃替尼	T790M+：含铂双药±贝伐珠单抗（非鳞癌）

NCCN指南（Version 3.2025）		
	首选	其他推荐
一线治疗方案	奥希替尼	埃万妥单抗+拉泽替尼 /埃万妥单抗+培美曲塞+顺铂/卡铂（非鳞癌）
后线治疗方案	寡进展型：奥希替尼/埃万妥单抗+拉泽替尼 广泛进展型：埃万妥单抗+培美曲塞+卡铂（非鳞癌）（一线未使用埃万妥单抗）、阿法替尼+西妥昔单抗（腺癌/鳞癌）	

资料来源：非小细胞肺癌 CSCO 诊疗指南（2024 版）、非小细胞肺癌 NCCN 诊疗指南（Version 3.2025）、开源证券研究所

第三代 EGFR TKI 耐药后的治疗策略可以大致分为四类，包括 EGFR 靶点联合用药（或 EGFR 双抗）、免疫联合化疗、新一代 EGFR 抑制剂以及抗体偶联药物 ADC。

EGFR 靶点联合用药（或 EGFR 双抗）策略全球进度最快。截至 2025 年 6 月，全球有超十款 EGFR/cMET 双抗进入临床阶段。强生埃万妥单抗（EGFR/cMET 双抗）联合化疗治疗 EGFR TKI 耐药 NSCLC 患者已在全球范围内获批上市。除 EGFR/cMET 双抗，EGFR TKI+cMET 双口服方案也是目前策略之一。如赛沃替尼、特泊替尼和谷美替尼等小分子 cMET 抑制剂联合第三代 EGFR TKI 治疗 MET 扩增 EGFR 突变 NSCLC 患者显示积极治疗效果。

新一代 EGFR TKI 主要针对 C797S 等三次突变引起的靶向耐药性。截至 2025 年 6 月，有近 20 款针对 C797S 耐药突变的新一代 EGFR TKI 进入临床阶段。

在免疫联合化疗治疗策略中，依沃西单抗（PD-1/VEGFA 双抗）联合化疗进度

最快，已于 2024 年在中国获批上市。截至 2025 年 6 月，除获批上市的依沃西单抗联合方案，瑞拉芙普-α 联合方案（恒瑞医药）、PM8002 联合方案（普米斯/BioNTech/BMS）和 SCTB14 联合方案（神州细胞）也已进入中国注册临床阶段。

治疗三代 EGFR TKI 耐药后 ADC 药物包括 EGFR 单抗 ADC、EGFR 双抗 ADC、Trop2 ADC 以及 HER3 ADC。其中科伦博泰 Trop2 ADC（sac-TMT）进度最快，已在中国递交 NDA 申请。此外，百利天恒 BL-B01D1（EGFRxHER3 ADC）和公司 SYS6010（EGFR ADC）也已进入中国注册临床。

SYS6010 治疗 EGFR TKI 耐药 NSCLC 患者的 mPFS 明显延长，EGFR 野生型患者 ORR 数据优异。SYS6010 是全球首个在肺癌领域开展注册 III 期的 EGFR ADC，于 2025 年 AACR 大会披露的早期数据十分优异。SYS6010-001（CTR20231332）是 SYS6010 首个中国临床试验，根据于 2025AACR 披露的早期数据显示，SYS6010 三线及三线后治疗一线使用 EGFR TKI、二线使用含铂化疗后的非鳞状 NSCLC 患者后，患者 mPFS 长达 7.6 个月；二线治疗数据尚未成熟。经治疗后的 164 例患者发生的三级及以上的 TRAE 为 51.2%，显示 SYS6010 兼具较好的安全性。SYS6010 后线治疗 7 例 EGFR 野生型 NSCLC 患者的 ORR 达到 71.4%，数据优异。

图3：SYS6010 早期数据优异

靶点		EGFR/cMET双抗+含铂双药化疗				PD-1/VEGF双抗+含铂双药化疗				TROP2 ADC				EGFR ADC							
药物		埃万妥单抗+化疗				Ivonescimab				SKB 264				SYS6010/CP0301							
公司		康方生物				信达生物				科伦博泰				石药创新（新诺威）							
细分适应症		1L EGFR TKI耐药后				1L EGFR TKI耐药后				3L EGFR突变NSCLC		2L EGFR 突变NSCLC		后线EGFR mt/wt NSCLC							
试验阶段		全球III期				全球III期（中国数据）				中国注册II期		全球II/III期		中国II期							
试验编号		NCT04988295				NCT05184712				NCT05631262		NCT04152499		CTR20231332							
披露/更新时间		2024ESMO 2024-09-14; 2024 ESMO-ELCC 2024-03-21;				2024 ASCO/JAMA 2024-06-06 2024 ESMO IO 2024-12-12				2025/3/12（官网说明 书）		2024 AACR 2024-04-09		2025 AACR Poster							
随访时间		18.1m				7.89m、17.6m				12.2 mo		17.2m		3.0m							
分组		2L				2L（中国数据）				3L+		2L+		ALL NSCLC	EGFR mt nsq		EGFR mt nsq with TKI耐药 和含铂化疗耐药		EGFR mt nsq with TKI 和含铂化疗耐药	EGFR wt nsq	
		Amivantamab + 卡铂/培美曲塞	Amivantamab + Lazertinib + 卡铂/培美曲塞	卡铂 AUC5 + 培美曲塞		EGFR TKI耐药nsNSCLC 依沃西单抗+培美曲塞+卡铂	EGFR TKI耐药nsNSCLC 培美曲塞+卡铂			SKB264	多西他美	Overall	EGFR mt		ALL	4.8mg/kg	ALL	4.8mg/kg			
样本量		131	263	263		161	161			91	46	43	22	164	102	49	19	9	78	38	7
患者基线	中位治疗线数	1L				1L								3L							
	脑转移患者	58 (44%)	120 (46%)	120 (46%)		21.70%	23.00%			20.40%				12.20%							
	Prior 3rd-generation TKI	100%	100%	100%		30.4% (1L) 55.9% (2L)	36.0% (1L) 49.1 (2L)			93.40%											
	Prior Osimertinib	97 (74%) -1L; 34 (26%) -2L	185 (70%) -1L; 77 (29%) -2L	181 (69%) -1L; 82 (31%) -2L		60.20%	57.10%														
有效性	cORR	64.00%	63.00%	36%		50.60%	35.40%	45.10%	15.60%	43.60%	60.00%			39.20%	46.90%	63.20%	88.90%	33.30%	34.20%	71.40%	
	DCR					93.10%	83.20%							93.10%	93.90%	94.70%	100.00%	92.30%	92.10%	85.70%	
	mPFS	6.3m 12.5m（境内）	8.3m 12.8m（境内）	4.2m 8.3m（境内）	7.06m (HR 0.46) 8.4m（脑转+HR 0.33）	4.8m 5.4m（脑转）	6.9m	2.8m	7.2m	11.5m		7.6m	7.6m				7.6m	7.6m			
	HR	0.48（vs 化疗）	0.44（vs 化疗）		0.46		0.3														
	mOS	17.7m (18m-50%)		15.3m (18m-40%)	17.1m	14.5m			22.6m	22.7m											
	HR	0.73（vs 化疗）			0.80		0.49														
安全性	AE	100%	100.00%	93.00%	99.40%	97.50%					98.20%										
	≥G3 AE	72%	92%	48%	61.50%	49.10%					53%										
	TRAE				98.10%	95.00%					97.60%										
	≥G3 TRAE				54.00%	42.90%	56.00%	71.70%	69.80%		51.20%										
	SAE	32%	52%	20%	41.00%	25.20%					31.10%										
	TRSAE						16.50%	41.30%			25.00%										
	DLT																				
	剂量减少（TRAE相关）											32.30%									
	停药（TRAE相关）				5.60%	2.50%					3.70%										
	死亡（TRAE相关）	2%	2%	0%							0										
剂量减少	41%	65%	15%							32.90%											
停药	18%	34%	4%							5.50%											
死亡	2%	5%	1%	0.00%	0.00%					3%											

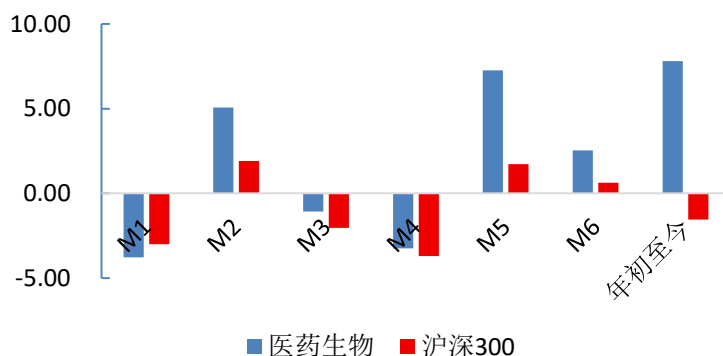
资料来源：2024 ESMO、2024 ASCO、2025 AACR、科伦博泰官网、开源证券研究所

2、6月第2周医药生物上涨1.4%，医疗研发外包涨幅最大

2.1、板块行情：本周医药生物上涨1.4%，跑赢沪深300指数1.66pct

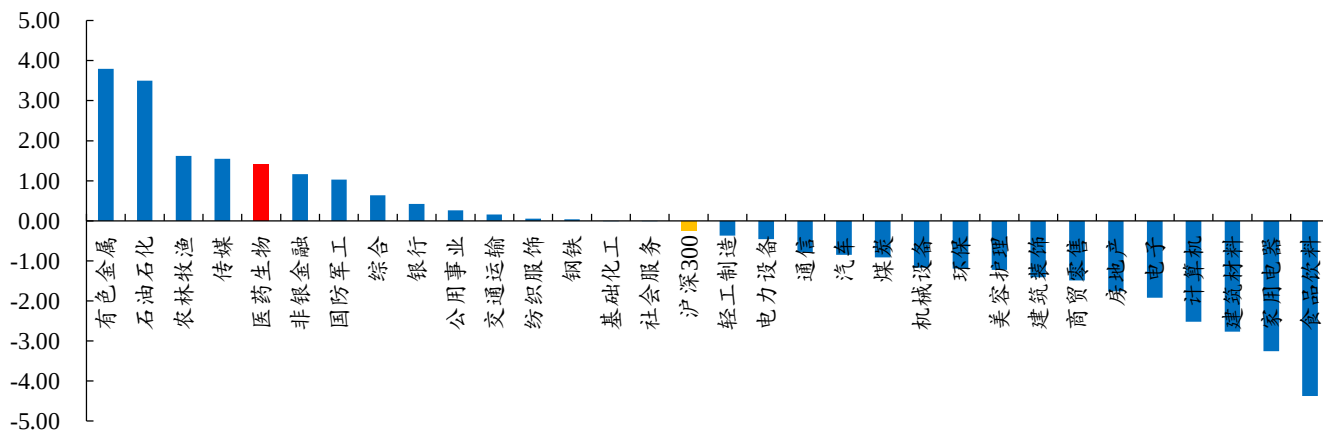
从月度数据来看，2025年初至今沪深整体呈现下行趋势。2025年6月第2周有色金属、石油石化等行业涨幅靠前，家用电器、食品饮料等行业涨幅靠后。本周医药生物上涨1.4%，跑赢沪深300指数1.66pct，在31个子行业中排名第5位。

图4：6月医药生物指数上涨2.55%（单位：%）



数据来源：Wind、开源证券研究所（截至2025.06.13）

图5：6月第2周医药生物上涨1.4%（单位：%）

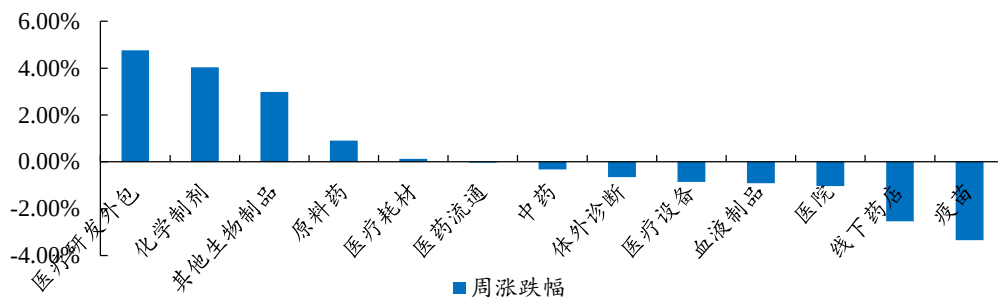


数据来源：Wind、开源证券研究所（注：2025.06.09-2025.06.13为6月第2周）

2.2、子板块行情：医疗研发外包涨幅最大，疫苗跌幅最大

2025年6月第2周多数板块处于上涨态势，本周医疗研发外包板块涨幅最大，上涨4.76%，化学制剂板块上涨4.04%，其他生物制品板块上涨2.99%，原料药上涨0.9%，医疗耗材板块上涨0.13%，线下药店板块下跌2.53%，医院板块下跌1.04%，血液制品板块下跌0.92%，医疗设备板块下跌0.86%；疫苗跌幅最大，下跌3.34%。

图6：医疗研发外包涨幅最大，疫苗跌幅最大



数据来源: Wind、开源证券研究所

表4: 6月以来化学制药和化学制剂板块涨幅领先

子板块	M1	M2	M3	M4	M5	M6	年初至今	预测 PE (2025)	预测 PEG (2025)
中药	-4.94%	-1.15%	0.35%	-2.77%	4.39%	0.06%	-2.97%	20.33	1.63
化学制药	-2.91%	4.68%	1.78%	1.61%	11.31%	5.27%	25.44%	44.55	1.80
原料药	-2.92%	7.53%	-1.31%	-0.93%	10.83%	3.82%	21.48%	30.64	1.85
化学制剂	-2.90%	4.12%	2.40%	2.10%	11.40%	5.54%	26.21%	47.69	1.79
医药商业	-4.18%	0.72%	0.11%	0.25%	2.75%	0.30%	1.46%	14.04	1.06
医药流通	-3.92%	0.33%	-2.04%	-4.25%	3.89%	0.89%	-2.47%	12.68	1.21
线下药店	-4.84%	1.71%	5.60%	11.12%	0.33%	-0.99%	11.47%	18.12	0.82
医疗器械	-4.29%	6.26%	-4.00%	-5.49%	4.82%	0.58%	-0.42%	25.74	1.51
医疗设备	-5.34%	10.49%	-6.81%	-3.05%	5.76%	-0.27%	1.21%	27.94	1.49
医疗耗材	-1.97%	-0.11%	-1.14%	-6.78%	3.15%	1.40%	-3.07%	24.47	1.08
体外诊断	-5.23%	6.26%	-1.64%	-8.83%	4.98%	1.33%	-0.35%	22.26	2.83
生物制品	-3.21%	2.64%	-1.80%	-5.27%	7.42%	1.33%	4.72%	37.50	0.83
血液制品	-1.58%	-3.50%	0.09%	-3.67%	1.08%	1.95%	-2.84%	20.60	1.57
疫苗	-6.59%	3.66%	-4.86%	-9.52%	4.92%	-1.85%	-10.69%	38.78	0.60
其他生物制品	-1.32%	4.49%	-0.35%	-2.99%	11.37%	3.01%	19.56%	48.22	0.79
医疗服务	-3.90%	15.16%	-3.78%	-9.92%	5.71%	3.16%	10.47%	27.09	0.93
医院	-6.10%	15.06%	-7.53%	-6.32%	0.47%	0.03%	-1.75%	33.51	1.73
医疗研发外包	-2.34%	11.74%	-0.74%	-11.56%	8.34%	5.19%	16.07%	23.70	1.04

数据来源: Wind、开源证券研究所

表5: 子板块中个股涨跌幅(%)前5

		原料药		化学制剂		中药		生物制品		医药商业	
涨幅前5	1	永安药业	26.38	易明医药	38.49	康惠制药	30.93	赛升药业	36.35	百洋医药	28.89
	2	美诺华	23.03	昂利康	34.30	恩威医药	18.75	未名医药	16.08	一心堂	8.23
	3	博瑞医药	9.23	舒泰神	26.82	康缘药业	17.05	*ST 四环	11.30	塞力医疗	2.13
	4	浙江医药	4.79	泰恩康	22.02	众生药业	12.64	百普赛斯	9.48	九州通	1.68
	5	九洲药业	4.32	海辰药业	21.92	太极集团	5.32	百济神州-U	9.09	开开 B 股	1.00
跌幅	1	河化股份	(9.23)	*ST 双成	(9.00)	万邦德	(12.17)	康乐卫士	(12.33)	人民同泰	(16.67)
	2	新天地	(8.87)	海南海药	(6.72)	龙津退	(6.94)	万泰生物	(10.20)	*ST 荣控	(6.48)

前 5	3	新诺威	(6.46)	恩华药业	(6.66)	生物谷	(6.77)	赛伦生物	(9.23)	大参林	(5.84)
	4	花园生物	(5.58)	复旦复华	(5.74)	广誉远	(6.53)	欧林生物	(8.37)	益丰药房	(4.87)
	5	森萱医药	(4.86)	兴齐眼药	(5.29)	九芝堂	(4.34)	三生国健	(7.41)	开开实业	(2.91)
		医疗研发外包		医疗服务		医疗设备		医疗耗材		体外诊断	
涨 幅 前 5	1	睿智医药	27.81	澳洋健康	35.01	三诺生物	8.03	华强科技	11.06	浩欧博	28.04
	2	毕得医药	10.90	*ST 生物	7.47	伟思医疗	2.38	南卫股份	9.57	热景生物	9.51
	3	诺泰生物	10.39	三博脑科	3.52	天智航-U	2.11	惠泰医疗	6.35	艾德生物	3.35
	4	药明康德	6.67	盈康生命	2.04	迈瑞医疗	2.06	可孚医疗	3.35	奥泰生物	3.30
	5	昭衍新药	5.04	迪安诊断	1.14	海泰新光	1.02	奥精医疗	2.49	明德生物	2.07
跌 幅 前 5	1	阳光诺和	(6.97)	ST 中珠	(9.34)	中科美菱	(6.94)	微电生理	(6.03)	英诺特	(6.24)
	2	数字人	(5.07)	贝瑞基因	(7.24)	奕瑞科技	(6.22)	赛诺医疗	(5.28)	新产业	(3.91)
	3	成都先导	(3.50)	创新医疗	(5.51)	澳华内镜	(5.65)	ST 凯利	(5.00)	安图生物	(3.58)
	4	和元生物	(3.05)	金域医学	(4.93)	山外山	(5.13)	三友医疗	(4.59)	亚辉龙	(3.57)
	5	百花医药	(2.96)	诺禾致源	(3.96)	翔宇医疗	(4.76)	佰仁医疗	(4.41)	九安医疗	(3.47)

数据来源：Wind、开源证券研究所

3、风险提示

- (1) 政策波动风险。医保政策、价格调整等政策可能对医药行业产生影响。
- (2) 市场震荡风险。若市场风险偏好改变或公司成长性预期调整，可能影响公司估值稳定性。
- (3) 医保未准入风险。医保谈判结果还未正式落地，还需要以实际医保谈判结果为准。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn